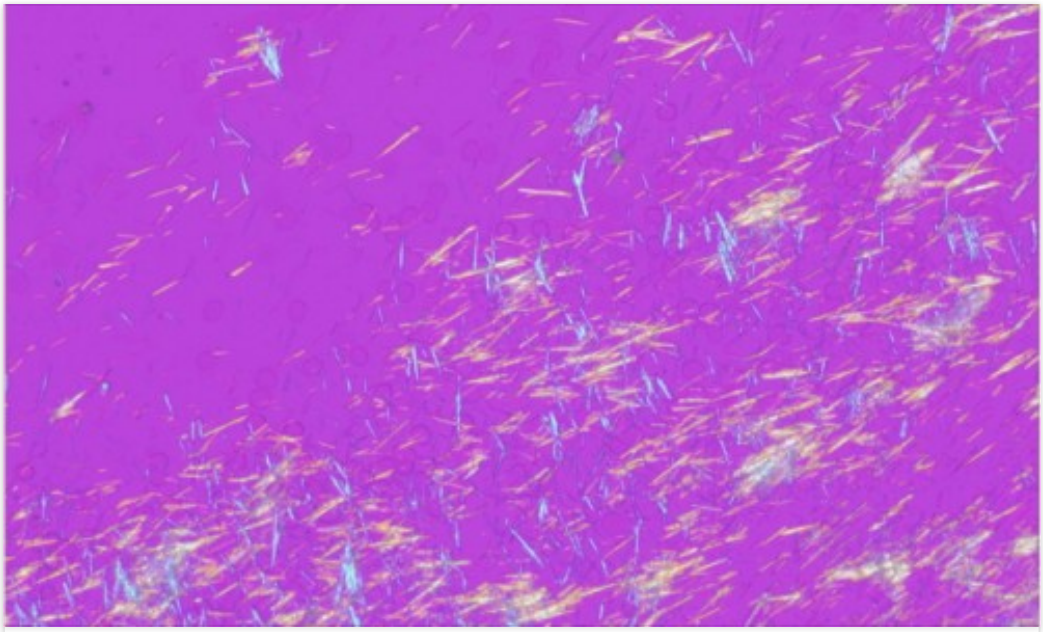
통풍에 대해 간략하게 정리해보았습니다

유성우
2020.10.21. 10:28 조회 168

댓글 2 URL 복사

https://www.ekjm.org/journal/view.php?number=25540



New Classification Criteria and Guideline for Management of Gout
Korean J Med > Volume 93(4); 2018 > Article What's new? Korean J Med 2018;93(4):344-...
www.ekjm.org

최근 통풍 환자분들을 보다 보니 좀더 명확한 치료 기준을 공유해야할 것 같다는 생각이 들어 작성하게 되었습니다.
가끔 환자분들이 관련 내용을 물어보실 때 급하게 찾아볼 용도이기도 하구요 ㅎㅎ

우선 올해 미국에서 CARE 연구를 정리한 새로운 가이드라인이 나왔으나 febuxostat의 심질환 악화 가능성에 대해 모호한 결과를 보이고 인종간 allopurinol의 s/e 차이로 인해 (서양인 1% : 한국인 12%) 1차 약제 선택이 달라야 한다는 내용이 있어 위 링크의 국내 논문을 중심으로 기타 검색 포함 간략하게 정리해보았습니다.

1. 치료 목표

1) 급성 통풍관절염을 가능한 한 빨리 그리고 부드럽게 종결시킨다. 2) 급성 통풍관절염의 재발을 예방한다. 3) 관절이나 신장 또는 다른 부위에 있는 요산의 침착이나 요산 결정에 의하여 발생되는 합병증을 예방하고 정상화시킨다. 4) 만성 신장병, 비만, 이상지질 혈증, 고혈압, 당뇨병, 죽경화증, 심장동맥병, 뇌중풍과 같이 통풍과 관련된 해로운 질환을 예방하고 정상화시킨다.

2. 고요산혈증

7.0 mg/dL 이상을 고요산혈증으로 정의함. 12시간 금식 후 측정
증상 없는 9.0 mg/dL 이하의 고요산혈증 - 특별한 약물 치료를 시행하는 경우는 거의 없다.
9.0 mg/dL를 초과하는 경우 - 신장 손상의 가능성이 커지므로 환자에 따라 요산을 저하시키는 약물 치료를 고려

3. 급성통풍관절염

환자는 가능한 한 움직이지 말고 안정을 취해야함
콜히친(colchicine), 비스테로이드항염제(NSAIDs), 글루코코르티코이드 중에서 선택

NSAIDs - 신질환 동반시 금기, 글루코코르티코이드 고려
글루코코르티코이드 - 당뇨, 감염성 질환 동반시 주의

발작 시작 24시간 이내에 치료를 시작하는 것이 중요

또한 완전한 치료 중단은 급성 통증의 완전한 관해가 이루어지고 2-3일 이내에 안전하게 행해질 수 있다.
치료 기간은 몇 일(증상 시작 몇 시간 이내에 치료를 시작한 경우) 이내부터 몇 주(증상 발생 4-5일 이후에 치료를 시작한 경우)까지 다양함.
대부분의 환자들은 증상 발생 12-36시간 이내에 치료가 시작된 경우 5-7일 정도의 치료를 필요로 한다.
2주 이내 소실되지 않으면 기타 질환 가능성 고려

요산 저해제 - **새로 처방하는 것은 금기, 복용 중이라면 지속**하도록 (요산의 fluctuation이 생기지 않도록 해야함)
새로 처방 시에는 염증 가라앉고 2주 후에 시작

4. 통풍 발작의 예방

0.6 mg의 콜히친을 매일 한 알 또는 두 알을 복용
NSAIDs나 저용량의 글루코코르티코이드를 콜히친 대신 사용가능

혈청 요산 농도가 정상을 유지하고 3-6개월 동안 급성 통풍 발작이 없을 때까지 지속
만성 결절 통풍 환자의 경우 최소 6개월 이상 예방 치료를 유지

5. 만성 통풍 환자에서의 고요산혈증 치료

1차로 febuxostat 권장
allopurinol은 중증피부약물이상반응 등 일어날 수 있어 HLA-B5801 유전자 검사를 필요로 한다

Febuxostat를 처음 사용하는 경우에는 40 mg을 하루에 한 번 투여
2-4주 후에 혈청 요산 검사를 추적하여 6.0 mg/dL 이하로 조절이 잘되면 유지, 높아지면 80 mg으로 증량

통풍 결절이 없는 경우에는 **6.0 mg/dL 이하**로, 통풍 결절이 있는 경우에는 **5.0 mg/dL 이하**로 유지

위 내용만 따르기에는 보험 심사기준을 고려하지 않은 부분이 있을 수 있어 반드시 확인 후 오더 내시길 바랍니다.
부족하거나 사실과 다른 내용이 있다면 댓글로 남겨주세요! 감사합니다 :)

등록순 최신순

클린봇

정성묵

좋은 내용입니다. 일차로 febuxostat를 사용해야겠네요. 혹시 약물의 투여 중단 기준이 따로 있는지 궁금하네요. 혈압약이나 스타틴처럼 지속적 투여쪽으로 가야하는지요

2021.01.04. 13:10 답글쓰기

유성우 작성자

식단 조절을 통한 uric acid 강하 효과가 크지 않아 지속적 투여를 기본으로 하는 것으로 알고 있습니다.

2021.02.01. 13:55 답글쓰기

유성우

댓글을 남겨보세요

등록